



Formation ETP

Module 2 : Construire avec le patient une démarche d'éducation thérapeutique

Concevoir et animer

Organiser et évaluer son projet d'ETP

Formatrice :
Dates :





Thèmes et objectifs



L'animation de groupe



L'organisation : Identifier les étapes nécessaires à la mise en place de son programme d'ETP



L'évaluation : identifier pourquoi, quoi évaluer et comment (les outils)



Planifier l'intégration des principes de l'ETP dans sa pratique

J4 : l'animation de groupe

- L'animation de groupe
- Mises en situation pratique
- Animation de séquences avec les différents outils et techniques (cartes symptômes ou traitements, mise en situation, photolangage...)

J5 : proposer le programme d'ETP à un patient et évaluer

- Retour sur la session précédente
- Retour sur l'animation de groupe
- Mettre en place un projet d'éducation thérapeutique

J6 : l'intégration de l'ETP dans sa pratique

- L'évaluation : Quoi, Quand, Comment et Pourquoi évaluer?
- Intégrer l'ETP dans sa pratique professionnelle



LE DÉROULEMENT D'UN ATELIER DE GROUPE



Introduction

- dire Bonjour et bienvenue...
 - se présenter
- de quoi va-t-on parler ? rappel du contexte, du sujet

Présentation des participants

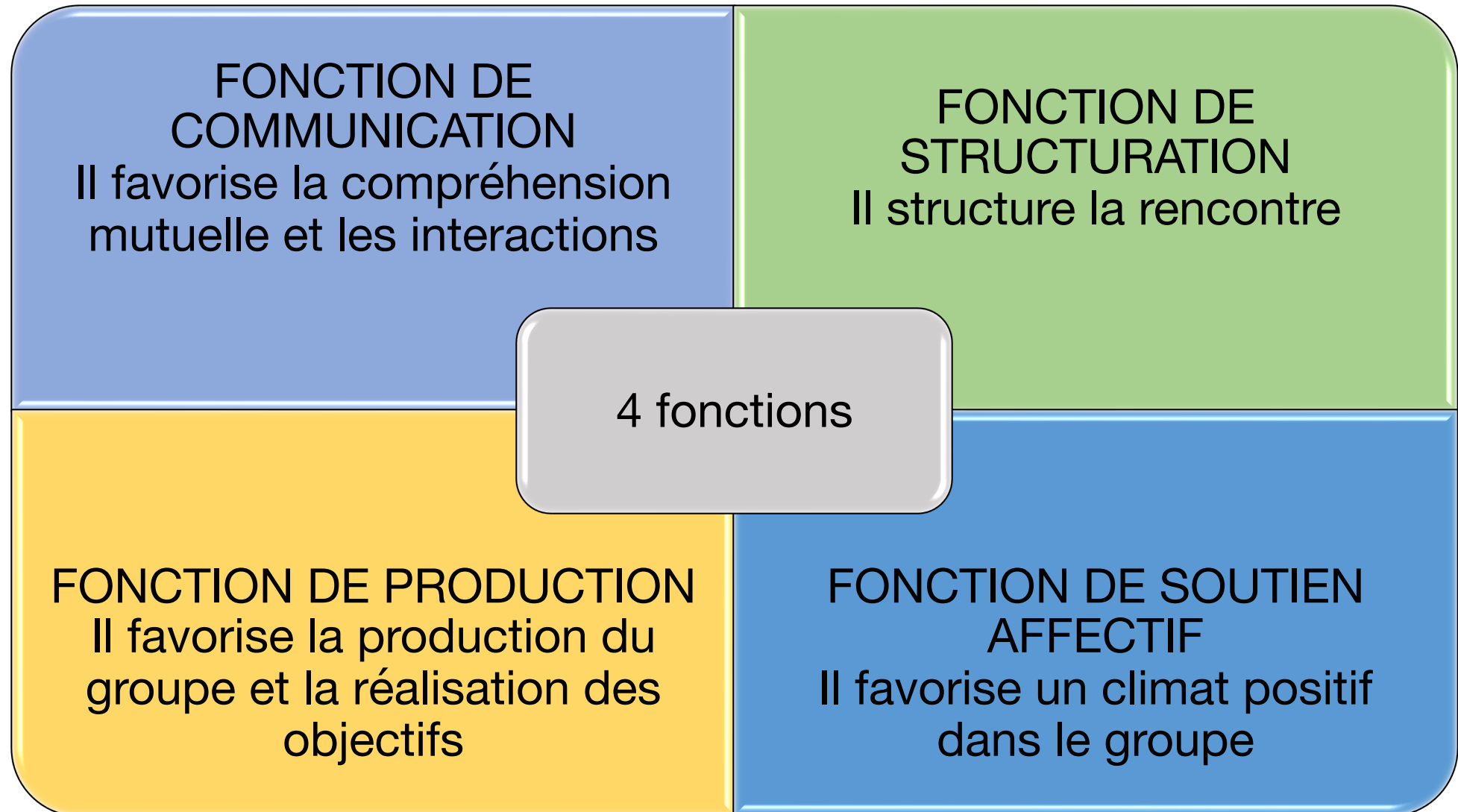
- donner des consignes claires pour se présenter en fonction du sujet abordé dans l'atelier et de la place de l'atelier dans la chronologie du programme
 - 3 situations :
 - 1^{ère} fois qu'ils se rencontrent
 - 1 ou 2 personnes viennent dans un groupe déjà formé
 - 2^{ème} rencontre du groupe

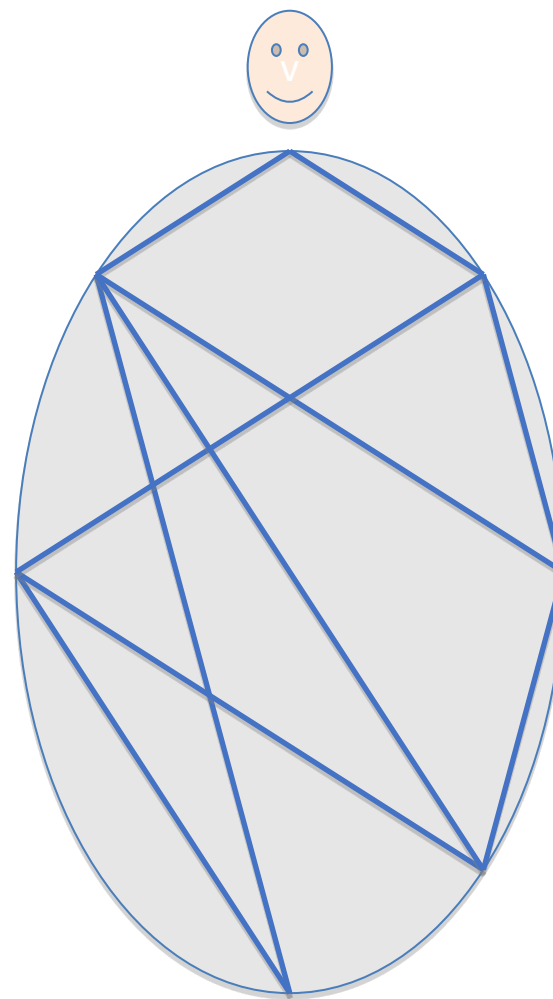
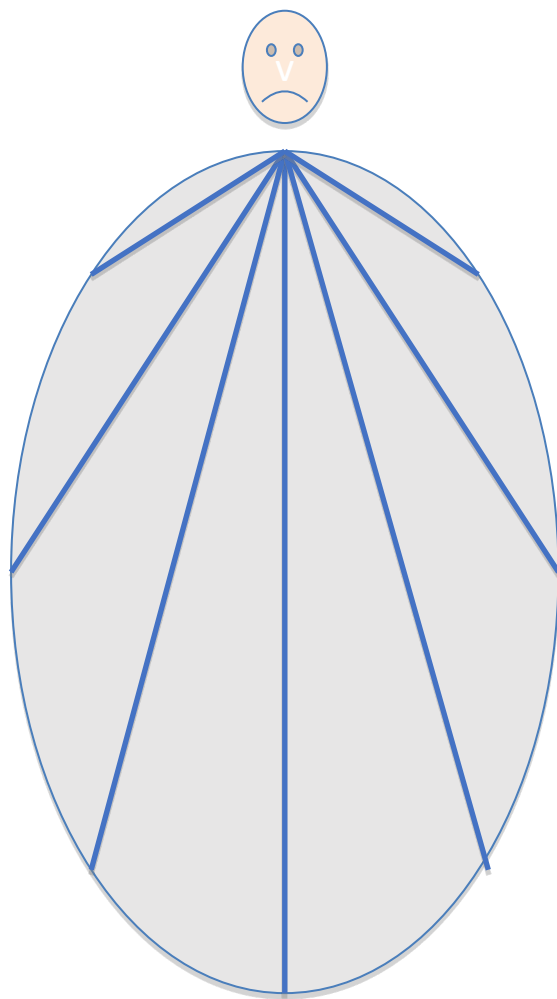
Présentation de la séance

- pourquoi on est là ? les objectifs (rédigés)
 - comment on va travailler ?
- fixer les règles de fonctionnement (afficher)
- la logistique : déroulement, horaires, pauses,...

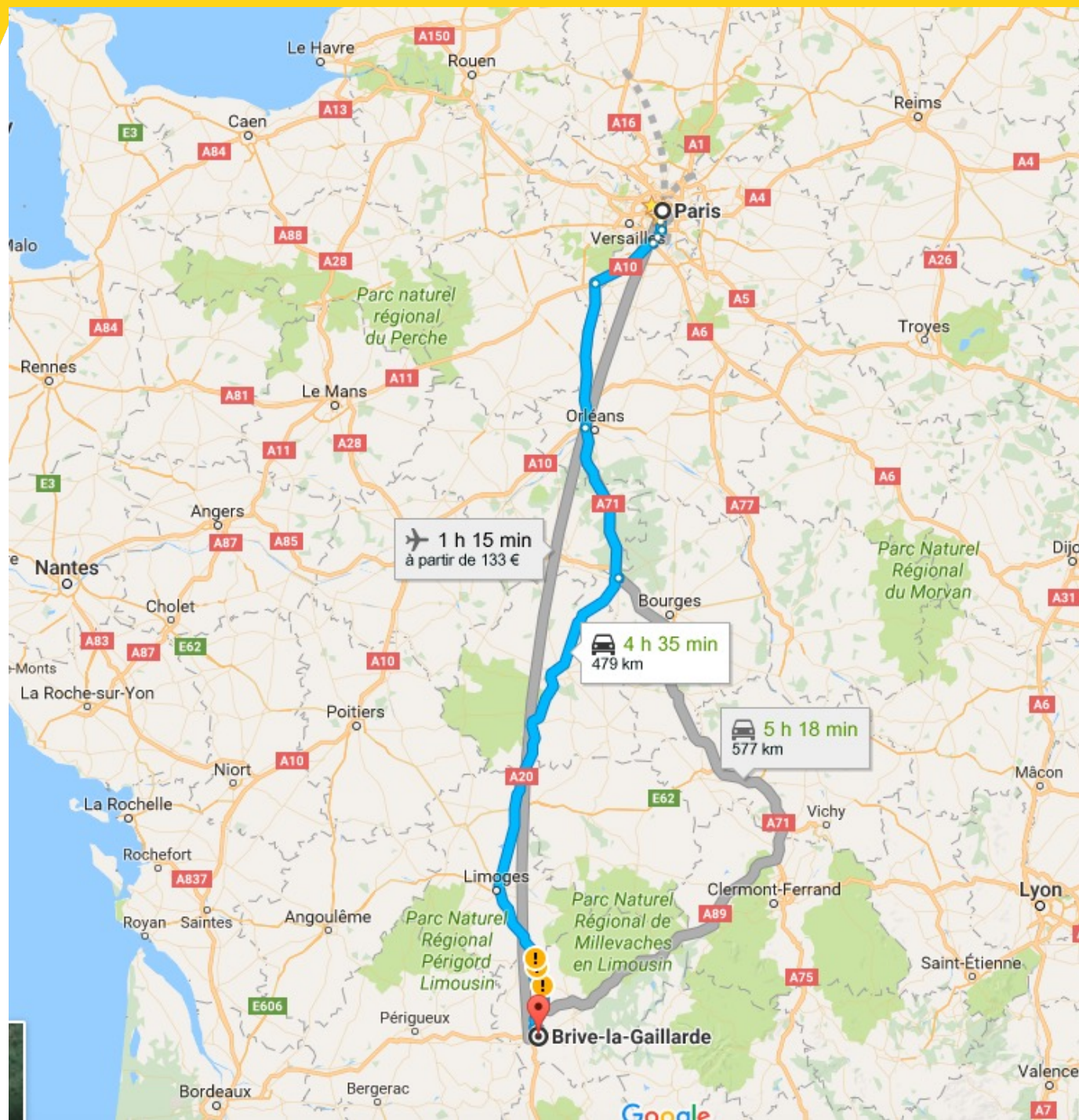
LES QUALITÉS D'UN ANIMATEUR







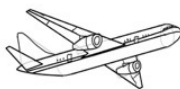
Quel itinéraire choisir?



*Annoncer les objectifs, l'activité
Décrire le déroulement
Ecrire les consignes (les avoir préparées à l'avance)*

LANCEMENT : LE DÉCOLLAGE

ANIMATION



*Favoriser l'expression individuelle des patients et les échanges (techniques d'animation et outils pédagogiques)
Prendre en compte toutes les propositions émises par les patients
Rester neutre, renforcer positivement...*

*Rappeler les objectifs
Synthétiser et reformuler les idées du groupe avec leurs propres mots
Conclusion avec messages clés (préparés en amont, consensuels au sein de l'équipe)*

SYNTHÈSE : L'ATERRISSAGE

Les grands types de participants

Les silencieux

LES GRANDS TYPES DE PARTICIPANTS

à une réunion

LE TIMIDE

Augmenter sa confiance en lui :
lui poser des questions faciles

LE ROUPILLEUR

Ne s'intéresse à rien
L'interroger sur sa propre
expérience
L'amener à donner
des exemples concrets

LE SAGE

C'est une aide précieuse
L'utiliser
Lui faire apporter
sa contribution

LE RUSE

Essaye d'attraper l'animateur
Utiliser les questions
en retour ou relais

LUI, IL EST CONTRE

Faire jouer son ambition
Si possible utiliser
ses connaissances et
son expérience

LE BAVARD

L'interrompre, avec tact
 limiter son temps de parole
(rupture du regard et
geste de la main)

CELUI QUI SAIT TOUT

Si c'est vrai le traiter
comme le sage
Faire en sorte que le groupe
sape ses théories

LE GRAND SEIGNEUR

Ne pas le critiquer
Utiliser la technique du
"oui, mais"

LE BAGARREUR

Rester calme
Ne pas se laisser
entraîner
Empêcher de monopoliser
le débat

Les perturbateurs

Les résistants

- Le grand seigneur
 - Le bavard
 - Le rusé
- Si trop bavard, faire un résumé de ce qui a été dit et renvoyer au groupe une question qui suscite sa réaction « qu'en pensez-vous ». Vous diriger vers la personne, le toucher éventuellement.
 - Utiliser l'humour, la bienveillance et de la détermination. Rester neutre. Pousser à l'échange,, pas la division. Le Rire, l'humour, la bonne humeur sont des atouts notables.
 - Ne pas se sentir visé ou remis en question ou agressé. Quelque fois il s'agit d'un test mais sans gravité.



Les RESISTANTS

- Le bagarreur
 - Celui qui sait tout
 - Lui, il est contre
- L'amener à préciser son raisonnement. Demander au groupe ce qu'il en pense, ce qui suscite une réflexion, un échange.
 - Si une personne cherche à vous déstabiliser, jouer avec l'humour,.
 - Ne pas se laisser entrainer, les ménager en montrant que vous êtes le garant des échanges, que vous êtes serein (respirez, souriez) mais déterminer.
 - Qu'est-ce qui vous fait dire cela, comment vous en êtes arrivé à cette conclusion. Et les autres, qu'en pensez-vous, qu'est-ce que cela vous dit?

- Le roupilleur
 - Le timide
 - Le sage
- Ne mettez surtout pas un timide près de vous, ni ne lui poser PAS de questions directes. Utiliser les sous-groupe pour voir son attitude . S'il parle, son avis est donné en plénière via le rapporteur donc il s'exprime...
 - Ne réprimandez pas le roupilleur mais utilisez plutôt l'humour pour lui donner l'envie de vous rejoindre ou au moins qu'il ne perturbe pas.



A retenir pour la gestion de groupe

*Ecoute
Bienveillance
Confidentialité
Respect de l'autre et de ses idées
Chacun s'exprime à son tour
Poser des questions
Prendre du plaisir*



Rappeler les
règles du
groupe



La régulation
des
personnalités
est facilitée par
le travail en
sous groupe



Insister sur le
caractère
unique des
expériences



Leur montrer
qu'on entend
leur ressenti ou
leurs
remarques et
renvoyer vers le
reste du groupe



Éviter de
contredire



Porter attention
à sa
communication
verbale et non
verbale :
marquer
individuellement
du regard,
posture
ouverte,
empathique,
ton...



Les fonctions d'une clôture



CONSOLIDER LES APPRENTISSAGES ET CLARIFIER LES IDÉES PEU CLAIRES



RÉVISER CE QUI A ÉTÉ APPRIS



CÉLÉBRER CE QUI A ÉTÉ APPRIS



PENSER AU FUTUR : ÉLABORER UN PLAN D'ACTION, SE FIXER DES OBJECTIFS D'APPLICATION



DISCUTER DE STRATÉGIES POUR ANTICIPER D'ÉVENTUELS OBSTACLES



RÉCOMPENSER LES PARTICIPANTS



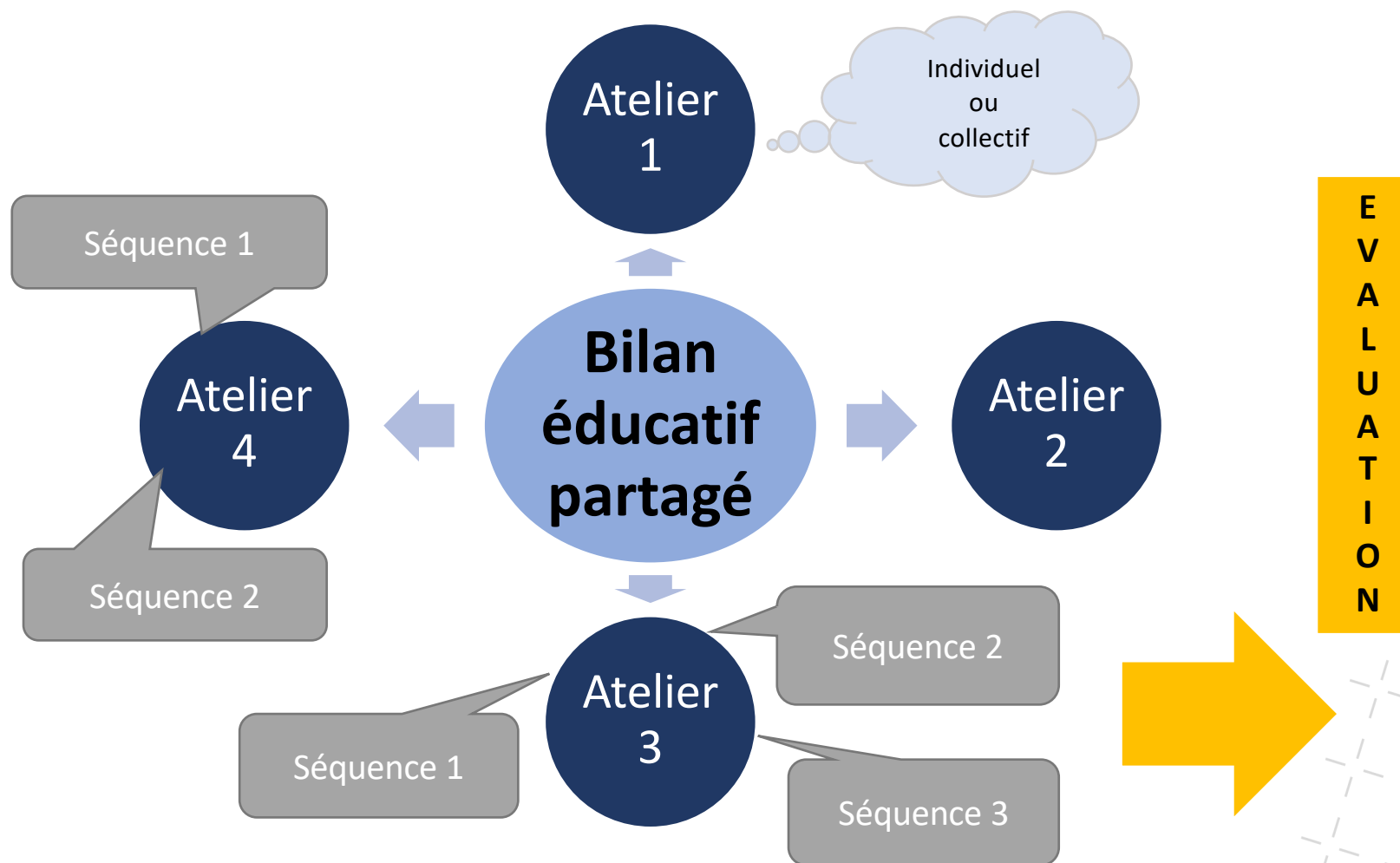
REMERCIER LES PARTICIPANTS POUR LEUR CONTRIBUTION ET LEURS EFFORTS



DÉPLACER LA CONCENTRATION OBTENUE SUR LES APPLICATIONS POSSIBLE

CONCEVOIR UNE SÉQUENCE







Exemple d'atelier

Intitulé de la séance : Les manifestations de mon insuffisance rénale

Objectifs pédagogiques

- Enumérer ses symptômes
- Citer les signes d'aggravation de l'insuffisance rénale

Support :

- Un jeu de cartes « symptômes »
- Paper-board.

Description de l'animation

Question starter

« Comment se manifeste chez vous l'insuffisance rénale ? »

Animation :

L'animateur pose toutes les cartes sur la table. Les patients sont invités à choisir parmi les cartes proposées celles qui correspondent à leurs symptômes.

Ils notent les symptômes choisis sur un post-it. Tour de table, chacun commente son choix.

Synthèse et messages-clés

L'animateur procède à une synthèse selon les cartes qui auront été choisies. Il précise que toutes les cartes représentent des symptômes de l'insuffisance rénale mais à des stades divers de la maladie (débutante, modérée, sévère).

« Au début, les symptômes sont rares. Progressivement fatigue, perte d'appétit, vertiges, maux de tête, oedèmes, dégoût de la viande s'installent. Plus tardivement apparaissent des crampes, démangeaisons parfois importantes, nausées, vomissements, des signes d'anémie : essoufflement... Si l'un de ces symptômes apparaît, parlez-en à votre médecin. »

Liste des outils éducatifs

Série de cartes numérotées représentant chacune un symptôme. Sont intégrés au jeu : une carte « aucun symptôme » pour ceux qui n'ont pas de symptômes et une carte « autre symptôme » pour les symptômes non cités

Détail des cartes symptômes

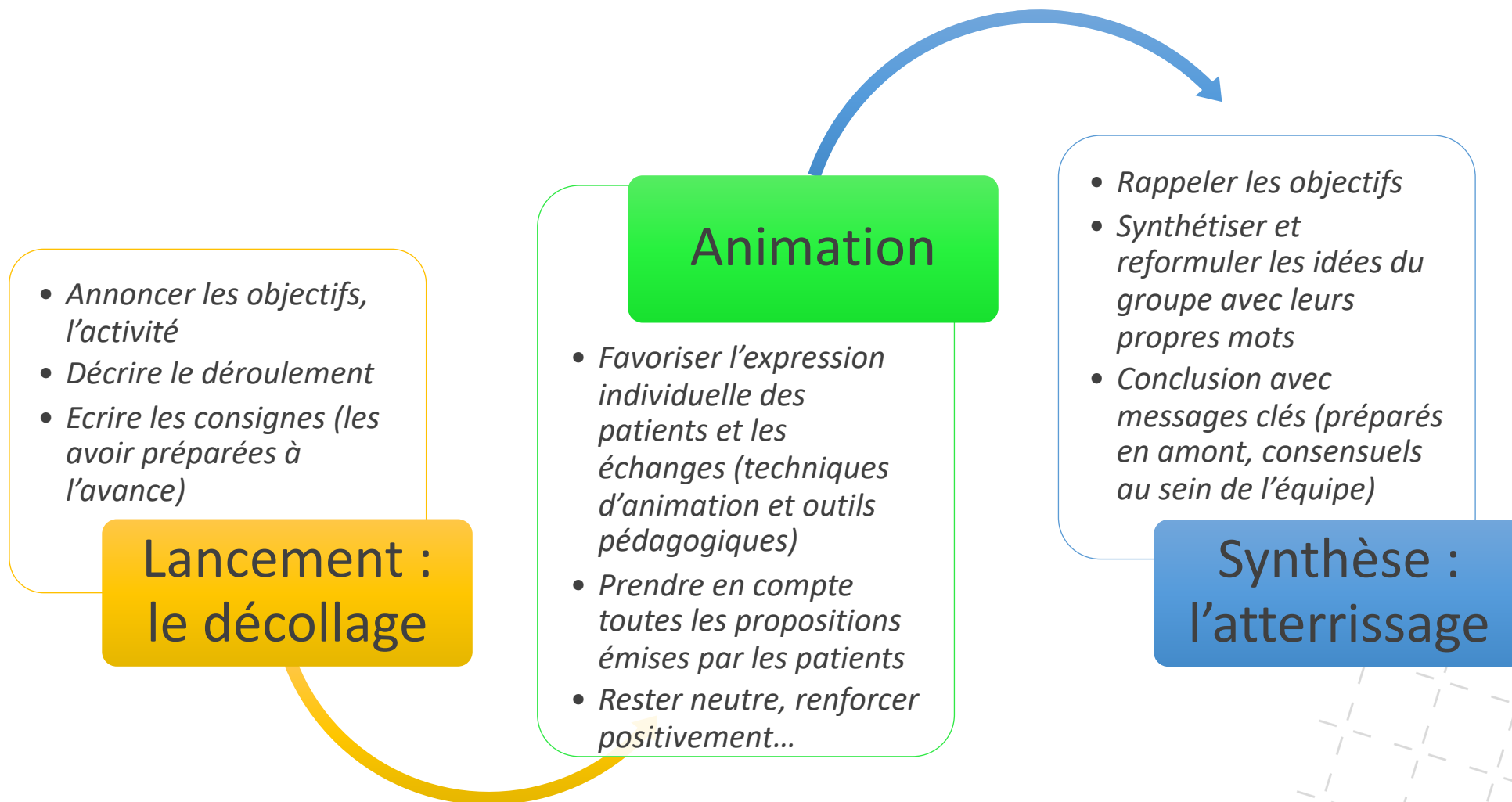
1. Je suis essoufflé(e)
2. Je me sens fatigué(e)
3. Je me sens faible
4. J'ai des vertiges
5. J'ai mal à la tête
6. J'ai des douleurs osseuses
7. Il m'arrive de vomir ou d'en avoir envie
8. Je n'ai pas d'appétit
9. Je suis dégoûté(e) par la viande
10. J'ai des crampes musculaires
11. J'ai la peau qui me démange
12. Je ressens des fourmillements dans les jambes
13. Mon visage et /ou mes chevilles gonflent
14. J'ai des problèmes de sommeil
15. J'ai des difficultés sur le plan sexuel
16. J'ai du mal à me concentrer
17. J'ai des impatiences dans les jambes surtout la nuit
18. Je n'ai aucun symptôme
19. J'ai d'autres symptômes (précisez)



Elaborer une séquence éducative

- Rédiger l'objectif de façon précise (les objectifs découlent des besoins “emblématiques” des patients identifiés en amont par une enquête de besoins)
- Proposer la méthode éducative la plus adaptée (correspondant aux critères de qualité).
 - Décrire la technique d'animation (timing)
 - Les consignes données aux participants
 - Le rôle de l'animateur
- Choisir (concevoir) un support adéquat

**ON CONÇOIT UNE SÉQUENCE
en fonction des besoins identifiés**



Rappel : les outils pédagogiques



Les outils : des fonctions pédagogiques et d'animation

- Un simple support (carte, vidéo...) n'est pas un outil pédagogique
- Il devient outil pédagogique :
 - Quand il est élaboré pour aider un public de patients à atteindre un objectif
 - Quand il facilite l'apprentissage des patients et prend appui sur ses principes
- Il facilite l'animation des séquences éducatives
 - Structure l'intervention, met en œuvre une méthode reproductible
- Il faut distinguer outil d'animation et outil d'information



Apport d'informations sur un mode pédagogique

- Un patient apprend mieux lorsqu'il est actif
- Le recours à des modalités éducatives dites verticales ou descendantes sera limité
- En pratique :
 - Susciter le questionnement
 - Explorer les savoirs et représentations
 - Expliquer clairement, utiliser un vocabulaire concret
 - Adapter sa logique professionnelle (scientifique) à celle du patient
 - Vérifier la compréhension
 - Donner une rétro-information

CAHIER DES CHARGES D'UN OUTIL

pour qu'il facilite l'apprentissage



SUSCITER
L'ANALYSE, LA
MOBILISATION
D'IDÉES, LE
QUESTIONNEMENT, LA
RÉFLEXION



FACILITER LES
ÉCHANGES
(POTENTIALITÉS
D'APPRENTISSAGE
NÉES DE LA
DYNAMIQUE DU
GROUPE)



FAVORISER
L'EXPRESSION
DU PATIENT
(TANT VERBALE
QU'ÉMOTIONNELLE)



RENFORCER LA
PARTICIPATION



SUSCITER
L'INTÉRÊT
(ATTRACTIF)



ÊTRE
COMPRÉHENSIBLE
PAR UN LARGE
PUBLIC

Thèmes

- Séance 1
- Mieux comprendre la maladie
- Séance 2
- Mieux comprendre son traitement
- Séance 3
- Faire face aux situations
- difficiles de la vie quotidienne

Objectifs

- [Lister les symptômes de la crise d'épilepsie](#)
- Décrire les mécanismes de la maladie
- Maîtriser les gestes à faire et ne pas faire en cas de crise
- Énumérer les examens complémentaires utilisés dans le diagnostic et le suivi de l'épilepsie
- Identifier les facteurs qui favorisent la survenue des crises
- Citer les différents moyens de traiter l'épilepsie
- Décrire l'influence des mesures hygiéno-diététiques sur le traitement
- Faire face aux situations sources de difficultés dans la vie quotidienne (conduite automobile, travail, voyages...)
- Identifier les ressources disponibles (familiales, médicales, sociales, psychologiques, associatives)
- Développer des compétences sociales (communication, gestion du « secret »)



Objectif :

Lister les symptômes de la crise d'épilepsie

Animation

- Le patient repère différents symptômes.
- On demande au patient de choisir
- ceux qui correspondent au(x)
- sien(s). Chacun commente son choix

Outil

CARTES SYMPTÔMES

Exemple :

« je ne sens rien venir, et je me réveille à l'hôpital », « Je sens une gêne sur l'estomac », « Je vois des points lumineux », « J'ai des mouvements désordonnés », « Je tiens des propos incohérents »,

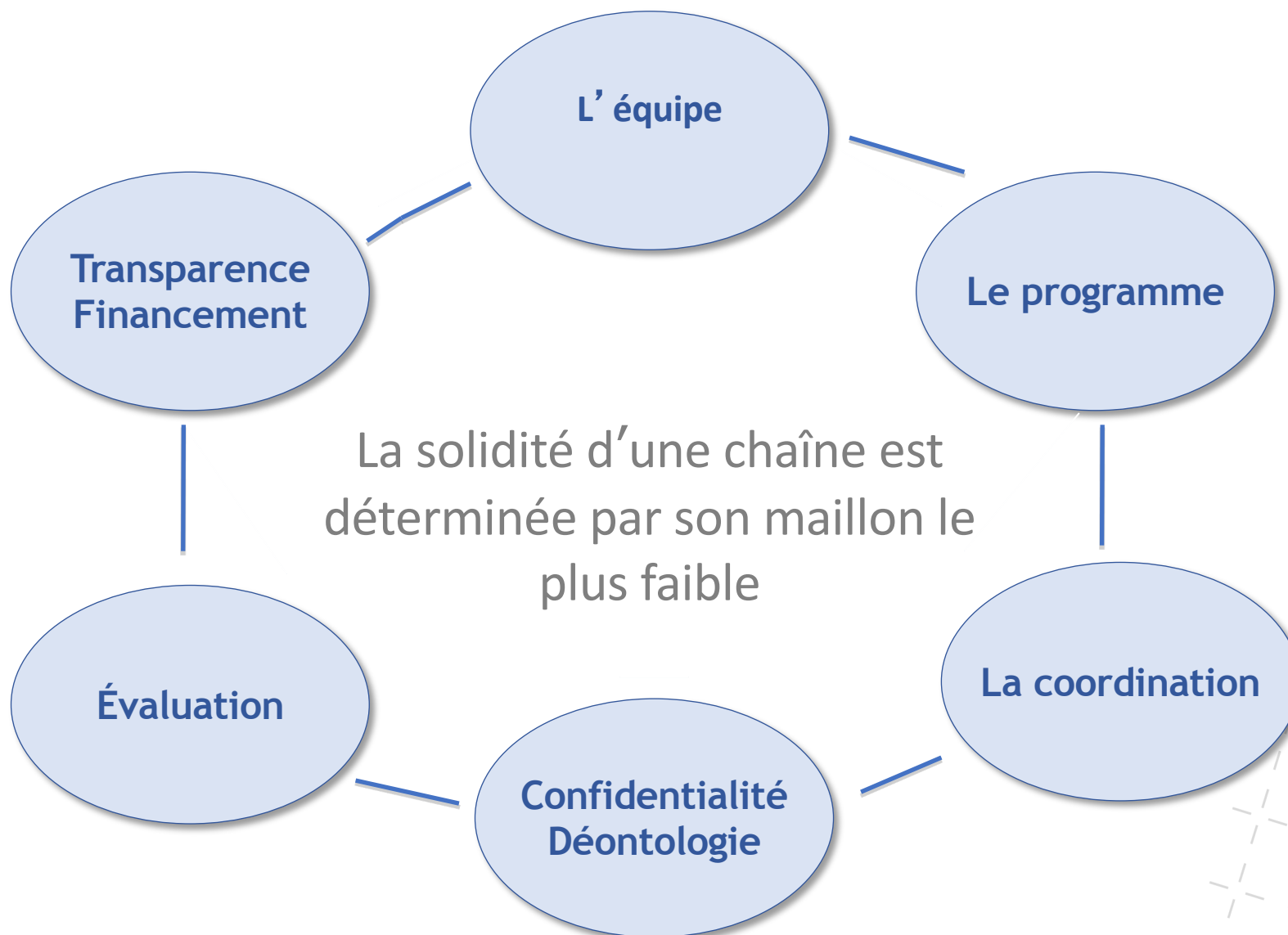
Educateur :

Restitution et synthèse

- Il y a une diversité des symptômes
- chaque personne peut présenter une forme différente de la maladie

Organiser son projet d'éducation thérapeutique





- Coordination : médecin ou un autre professionnel de santé ou un représentant dûment mandaté d'une association de patients agréée.
- L'équipe est pluriprofessionnelle : au moins deux professionnels de santé de professions différentes. Si le programme n'est pas coordonné par un médecin, l'un de ces deux professionnels de santé doit être médecin.
- Compétences : Un minimum de 40 heures de formation est nécessaire pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique.
 - Tous les intervenants dans un programme d'éducation thérapeutique (ETP) doivent justifier de compétences en ETP (arrêté du 14/01/2015).
 - Les attestations de formations délivrées par un organisme de formation doivent être fournies ; celles-ci doivent mentionner le nombre d'heures et le contenu de la formation suivie.

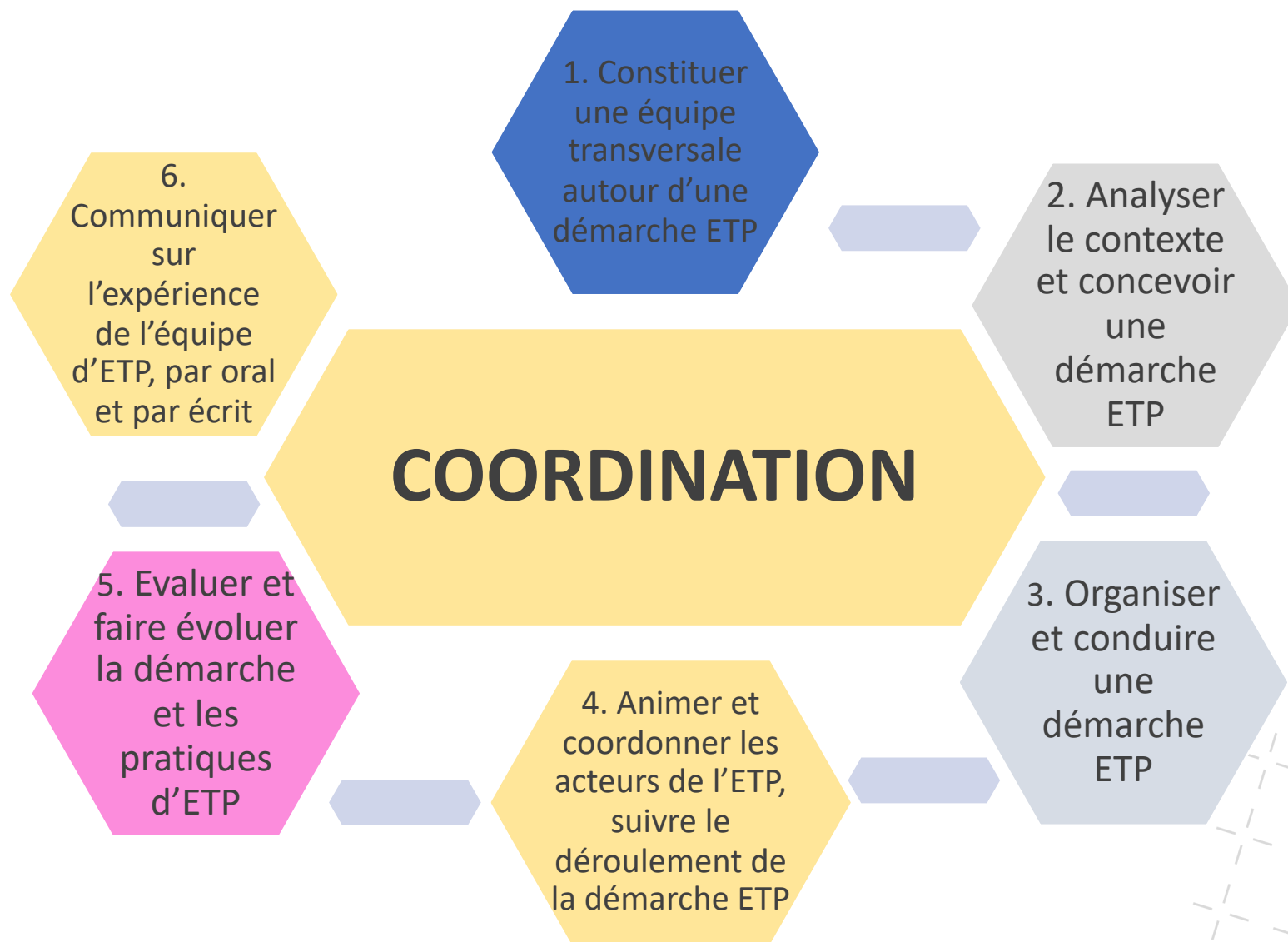
Compétences relationnelles (nécessité en effet de se former aux techniques de communication centrées sur le patient afin de maîtriser l'écoute active, d'accompagner le changement, de soutenir la motivation...)

Compétences pédagogiques (se former aux techniques pédagogiques **et d'animation** (pour être en mesure de faire s'exprimer chacun, ne pas émettre de jugement, renforcer positivement, synthétiser...),

Compétences méthodologiques (pour mettre en œuvre une démarche éducative personnalisée...) et organisationnelles (pour établir des liens avec les autres acteurs de l'ETP...),

Compétences biomédicales et de soins; l'arrêté sur les compétences précisant que ces dernières relèvent exclusivement des professionnels de santé





- Le programme concerne, sauf exception répondant à un besoin particulier à expliciter, une ou plusieurs des affections de longue durée exonérant du ticket modérateur (liste ALD 30) ainsi que l'asthme et les maladies rares ou un ou plusieurs problèmes de santé considérés comme prioritaires au niveau régional.
- S'appuyer sur des données relatives à l'efficacité potentielle du programme – à fournir
- Elaborer un programme qui soit adapté à la pathologie concernée : population cible définie en termes d'âge, d'évolution, de genre, critères de vulnérabilité, géographiques...
 - Monter pour ce faire un groupe de travail.
 - Analyser au préalable les besoins éducatifs des patients
 - Elaborer les objectifs pédagogiques du programme et les compétences attendues chez le patient (compétences d'auto-soins et d'adaptation)
 - Décrire le dossier patient, les modalités du programmes +/- outils pédagogiques et procédure d'évaluation

- Un programme d'ETP doit être personnalisé et s'adapter aux besoins éducatifs du patient invité à suivre le programme

Le bilan éducatif partagé

faire connaissance avec le patient invité à suivre le programme et d'identifier à cette occasion ses besoins, ses attentes et sa réceptivité à la proposition de l'ETP

La formulation avec le patient des compétences à acquérir

négociation avec le patient se fait soit en fin de l'entretien individuel du diagnostic éducatif, soit lors d'un second entretien

L'évaluation de l'atteinte des objectifs fixés en commun avec le patient

progrès du patient

La mise en œuvre personnalisée du programme

CO-CONSTRUCTION du programme
(1 ou plusieurs patients)

Le partenariat avec des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 est une OBLIGATION législative lorsqu'il existe un financement privé

MISE EN ŒUVRE du programme
(1 ou plusieurs patients)

Les acteurs associatifs peuvent être eux-mêmes COORDONNATEURS du programme

Interne

- Partager les informations et les décisions entre les différents acteurs (UTEP)
- L'organisation et les modalités d'échanges multiprofessionnels au sein de l'équipe sont prévues
- Un professionnel ressource parmi les professionnels impliqués dans le programme peut être choisi pour assurer la coordination avec le patient

Externe

- L'ETP étant intégrée aux soins, le programme doit s'effectuer également en lien très étroit avec le médecin traitant et autres professionnels de santé
 - Cohérence avec le SROS et collaboration ville-hôpital qui en découle
 - Structures d'ETP existantes hospitalières et non hospitalières (harmoniser l'offre)
 - Associations de patients

- La coordination a pour but de favoriser la cohérence et la continuité des soins.
- Une coordination de qualité ne peut se faire sans le dossier individuel d'éducation thérapeutique (la HAS propose les principales rubriques pour constituer un dossier d'éducation thérapeutique

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/etp_-_principales_rubriques_du_dossier_patient.pdf

HAS

HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Structuration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient dans le champ des maladies chroniques

Le guide méthodologique et les recommandations sont téléchargeables sur www.has-sante.fr

Principales rubriques du dossier d'éducation thérapeutique

Identité du patient (nom, prénom, date de naissance, maîtrise de la langue).
Maladie et traitement.

Dimensions du diagnostic éducatif

Projet personnel et professionnel.

Connaissances sur sa maladie.

Contraintes professionnelles : métier, situations à risque.

Profil du patient : ressources personnelles et sociales, potentialités d'apprentissage, motivations, centres

- Le patient doit bénéficier des informations le concernant et donner son accord préalablement aux échanges entre les acteurs.

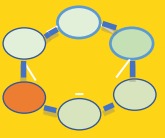
- **Arrêté du 30 décembre 2020** relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de déclaration et modifiant l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient
- La procédure d'information du patient concernant le programme est décrite (possibilité de sortie du programme, pas de partage des informations le concernant sans son accord...)
 - Recueil du consentement du patient à son entrée dans le programme
 - Déclarations et demandes d'autorisations concernant l'exploitation des données recueillies conformément aux dispositions légales (CNIL...)
- Un seule charte, nommée « CHARTE D'ENGAGEMENT »
 - Un modèle est fourni (arrêté du 14 janvier 2015, ANNEXE I bis)
 - La charte est destinée aux professionnels de santé, aux professionnels autres, et aux patients intervenants
 - La déontologie est insérée dans cette charte d'engagement
 - La charte souligne dans sa rubrique « liberté de choix » que « toute personne malade soit informée des programmes d'ETP susceptibles de la concerner et de leur contenu »

Le patient est informé de la possibilité de sortir du programme à tout moment et sans préjudice d'aucune nature.

- Les procédures permettant de garantir au patient participant au programme que **les informations transmises à ses interlocuteurs ne seront pas partagées, sans son accord, avec d'autres interlocuteurs, y compris au sein du programme et/ou de l'équipe soignante, sont décrites.**

- Le traitement des données : le responsable du programme est responsable du traitement des données avec comme obligations :
 - Tenue d'un registre interne qui décrit les traitements mis en œuvre
 - Assurer le droit à l'information des personnes dont les données sont traitées
 - Réaliser une étude d'impact relative à chaque traitement de données susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques
 - Désigner un délégué à la protection des données
 - Porter attention à l'encadrement contractuel des intervenants extérieurs
 - Assurer la mise en place des procédures permettant de garantir la sécurité et confidentialité des données
 - Signaler auprès de la CNIL tout incident de sécurité impliquant les données personnelles

- Réalisée sous forme d'auto-évaluation annuelle
 - Rapport d'activité avec file active, nombre séances, profil patients, ratio séances individuelles/collectives...
 - Évaluation du processus en terme d'organisation, de mise en œuvre et de déroulement du programme
 - Évaluation des résultats en terme de satisfaction des patients, des compétences...
- Réalisée sous forme d'évaluation quadriennale : reprise des 4 années écoulées
- Les rapports sont accessibles aux bénéficiaires du programme
- Le rapport d'évaluation quadriennale est transmis à l'agence régionale de santé
- Réalisée par le coordonnateur : auto-évaluation annuelle + évaluation quadriennale
 - Participation de toute l'équipe
 - Cette évaluation doit s'appuyer sur les recommandations et guides de la HAS éditées en mai 2014 sur le sujet.



- Multidisciplinarité des intervenants
- Formation des intervenants
- Coordination au sein du programme
- Information continue du médecin traitant
- Définition d'objectifs personnalisés
- Supports d'information
- Traçabilité de l'éducation thérapeutique
- Evaluation individuelle

- Quelle que soit la structure qui met en œuvre l'ETP (réseau, MSP...), la déclaration à l'ARS est indispensable sur la base du cahier des charges
- Il existe un forfait habituel pour un programme d'ETP en ambulatoire : 250€ à 350€/patient/an selon les régions (ARS via le FIR-Fond d'Investissement Régional).
- Il y a dans certaines structures des possibilités d'inclure l'ETP dans l'HDJ
 - <https://www.fhf.fr/expertises/finances/finances-budget-eprd/instruction-ndeg-dgos/r1/dss/1a/2020/52-du-10-septembre-2020-relative-la-gradation-des-prises-en>
- La déclaration de son programme à l'ARS ne vaut pas financement MAIS il en conditionne sa demande.

L'évaluation

Définition en ETP

- « En ETP, l'évaluation, c'est collecter des informations, les analyser et les comparer à des normes en vue de prendre des décisions
 - thérapeutique,
 - éducationnel,
 - organisationnel,
 - stratégique ou politique

Issus des travaux de 3 centres universitaires collaborateurs de l'OMS sur l'ETP (Louvain, Bobigny, Genève) Propositions pour l'évaluation de l'ETP. Ivernois JF (d') et al. Adsp n°58, mars 2007, en ligne

Évaluer le programme

1. Auto-évaluation annuelle
2. Évaluation quadriennale

- Analyse quanti-quali des points forts et faibles du programme
 - En se comparant au référentiel HAS
 - Pour prise de décision : qui vise à l'amélioration
- Une démarche collective :
 - points de vue de toute l'équipe et des bénéficiaires
 - A visée interne mais mention possible des mesures dans le rapport annuel à l'ARS
- A la date anniversaire de dépôt du programme
 - Socle de l'évaluation quadriennale

S'améliorer sur:

- Le contenu du programme
- Son organisation
- Le partage d'information
- La coordination

Une vision critères de
qualité HAS et non une
mesure de l'efficacité du
programme



Activité

Quels sont les indicateurs qui vont mesurer votre activité ? (juger si le programme « tourne » bien, s'adresse aux personnes prévues ...)



Processus

Êtes-vous bien organisés, coordonnés ? Le programme prend-il en compte les besoins des patients ? (pour améliorer les ateliers.)



Objectifs

Qu'apportent les ateliers aux patients ? Atteignent-ils leurs objectifs éducatifs ? (préparation de l'évaluation quadriennale)



Activité

Rapport d'activité :
patients, activités
éducatives, partage d'info...



Processus

Enchainement des étapes,
contenu des séances,
animation et outils
pédagogiques utilisés,
accessibilité du programme,
organisation et gestion des
plannings, coordination au
sein de l'équipe d'ETP...



Objectifs

Objectifs pédagogiques
atteints, Changements dans
la vie quotidienne du
patient, Qualité de vie,
Appréciation des facteurs
facilitant le maintien des
acquis



Activité

Rapport d'activité:
Indicateurs quanti

- Nb de patients
- Nb de séances
- Nb heures formateurs....



Processus

Réunions de
coordination+/- interviews
qui visent à l'auto-eval des
critères ARS

Rapport activité

Questio satisfaction patients

Auto-eval soignants



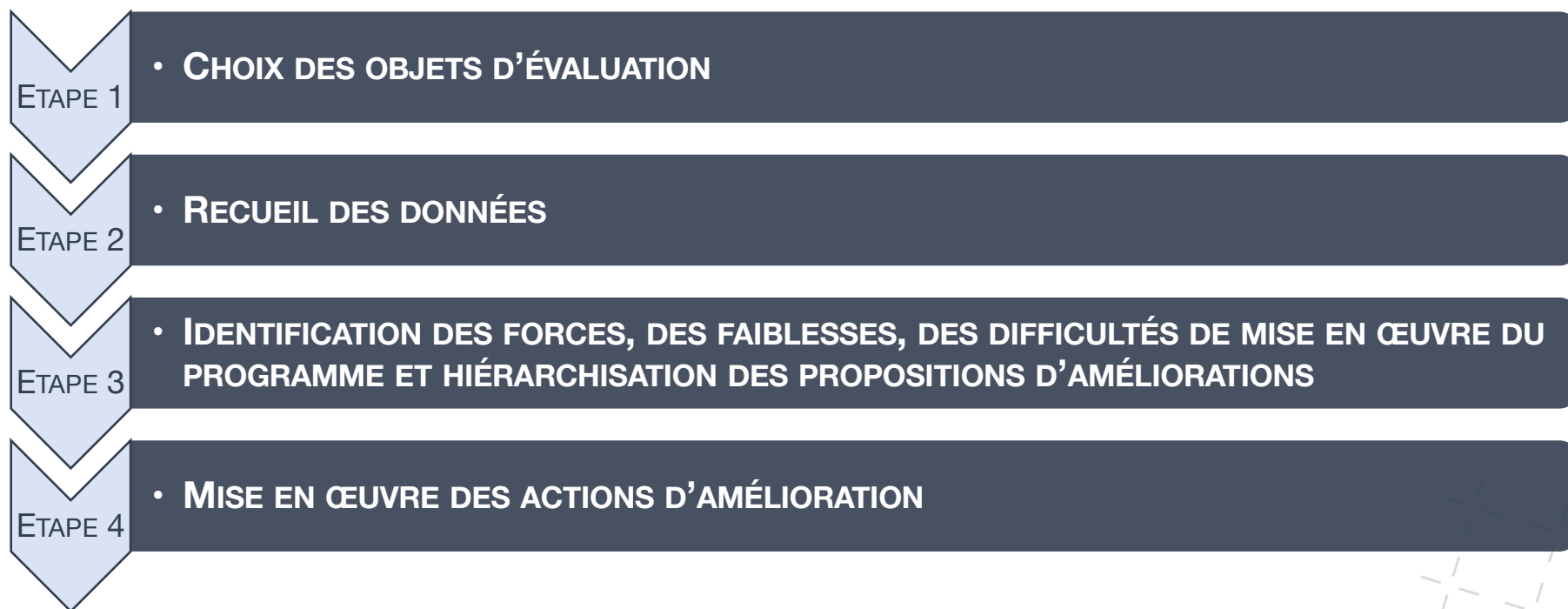
Objectifs

Evaluation chaque atelier

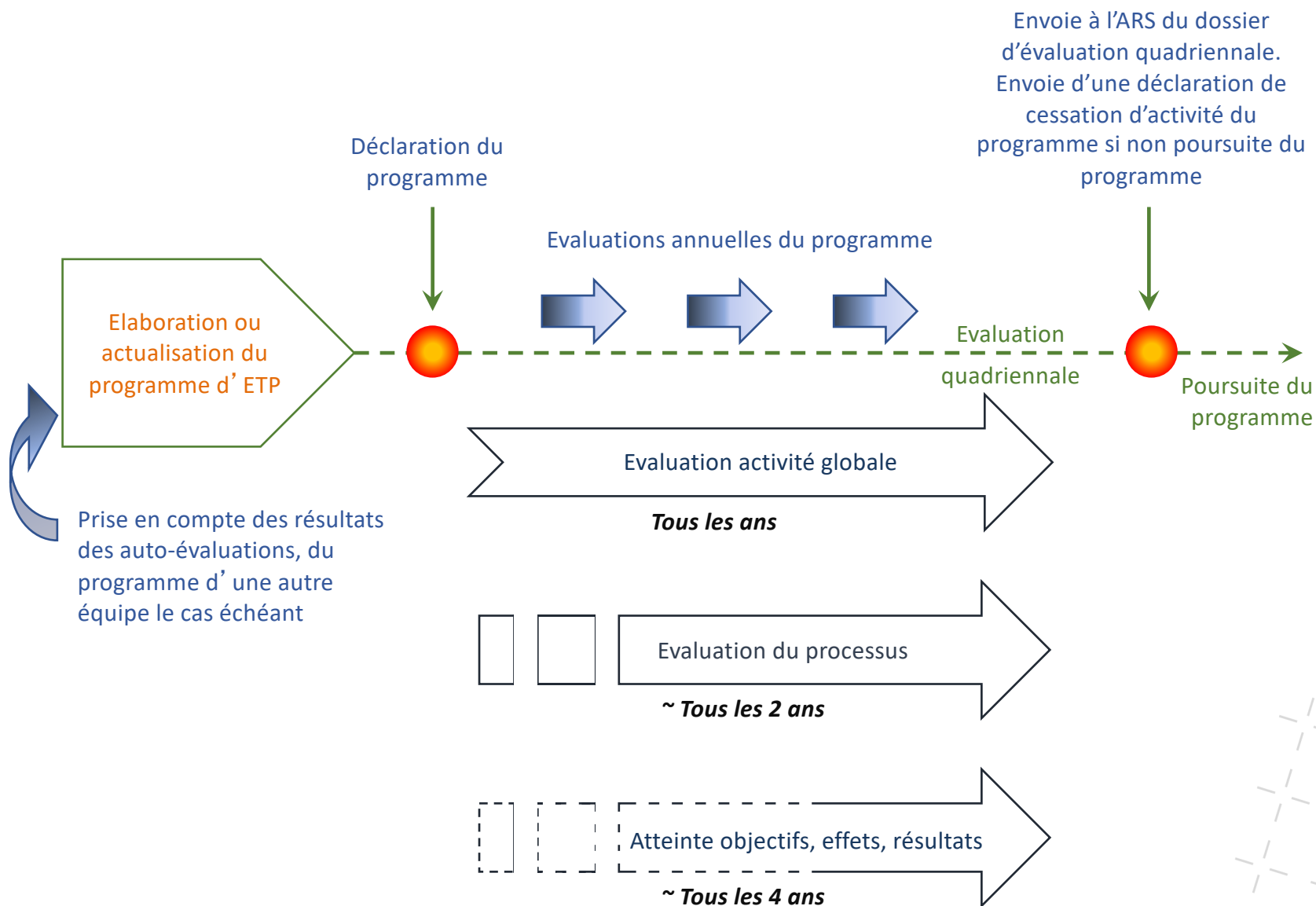
Indicateurs d'impact

Guide d'entretien bilan patients

Conduite de l'auto-évaluation annuelle en 4 étapes



- Evaluation de bilan ou de synthèse des 4 années de mise en œuvre
- Réalisée par l'équipe et le coordonnateur la 4ème année de fonctionnement
- Basée sur les résultats attendus de l'ETP ou « effets » et sur les évolutions du programme





Envisager les différents moyens d'intégrer l'ETP dans sa pratique professionnelle

Communiquer

Engager la suite



- Définir des objectifs clairs
- Repérer les rôles-clés
- Lister les tâches et Planifier les étapes
- Identifier les forces motrices / d'inertie
- Mobiliser les soutiens
- Définir des indicateurs
- Evaluer les contraintes



- Fait partie intégrante de la prise en charge
- Processus permanent
- Réalisée par des professionnels formés et engagés dans un travail d'équipe
- Définie en terme d'activités et de contenus
- Organisée dans le temps

- S'appuie sur une évaluation des besoins et de l'environnement du patient
- Adaptée au profil du patient
- Respecte les rythmes d'apprentissage
- Concerne la vie quotidienne du patient, les facteurs sociaux, psychologiques et environnementaux
- Inclut une évaluation



BONNE CONTINUATION,



TRAVAMUSEZ BIEN!!!



EDUSANTE@EDUSANTE.FR



BON À SAVOIR

Rôle de l'animateur de groupe





Rôle de l'animateur / groupe (1)

- Faire naître la confiance
- Alternier et varier les modes d'interactions
- Réguler les échanges
- Rester neutre, ne pas faire de jugements
- Veiller à l'expression individuelle de tous
- Prendre en compte toutes les propositions émises par les participants
- Veiller à ce que chacun s'écoute et respecte les paroles des autres
- Savoir écouter, se taire,
- Savoir reformuler, renforcer, recontextualiser
- Savoir résumer (faire régulièrement des synthèses)



Rôle de l'animateur / groupe (2)

- Soutenir la motivation
- Identifier les phénomènes de blocages, de découragements, sentiment d'euphorie ou de difficultés à se centrer sur la tâche, de fatigue, etc.
- Repérer les différentes attitudes
 - Les timides : les placer en face de soi, les aider, les valoriser
 - Les bavards : baisser la voix, se déplacer vers eux
 - Les monopolisateurs d'attention : les remercier et solliciter d'autres avis (« merci, c'est une opinion parmi d'autres »)
 - Les je sais tout : renvoyer au groupe



L'animateur doit être bien compris

- Parlez distinctement, fort
- Faites des phrases simples, courtes, claires
- Employez le langage des participants
- Soyez concrets (exemples, analogies...)
- Mettez vos messages clés en valeur
- Résumez périodiquement vos apports
- Soulignez la progression de votre animation (soignez les transitions)
- Vérifiez régulièrement que vous avez été bien compris
- Utilisez des visuels pour faciliter la compréhension



Accueillir tout participant

- Assurez vous d'avoir bien compris la question ou la remarque d'un participant avant d'y répondre
- Encouragez les questions, réactions, commentaires
- Observez les réactions non verbales des participants
- N'hésitez pas à formuler le non-dit (incompréhension, fatigue, intérêt...)





Compréhension entre participants

- Dissipez les éventuels malentendus dans les échanges
- Faites ressortir les différents points de vue exprimés
- Expliquez ou faites expliquer les sigles et abréviations non connus de tous
- Si nécessaire résumez les interventions des participants



- Instaurez un climat convivial
- Sourire, humour...
- Traitez les participants sur un pied d'égalité
- Encouragez les efforts, minimisez les échecs, faites ressortir les réussites
- Sécurisez les anxieux
- Regardez tout le monde (on oublie souvent les moins actifs)
- Soyez convaincu et dynamique
- ...





Rester maître de la situation

- C'est vous qui fixez les règles du jeu mais vous devez vous y tenir !
- Respectez le timing
- Marquez clairement le début et la fin des exercices
- Recentrez les participants sur le sujet
- Régulez la parole
- Constituez les équipes pour les travaux en groupes, désignez des participants pour les exercices si besoin





Potentiel d'aide mutuelle dans un groupe

- Partage d'information
- Confrontation des idées
- Discussion de sujets tabous
- Proximité
- Soutien
- Demandes mutuelles
- Aide à la résolution de problèmes
- Réalisation de tâches difficiles
- Force du nombre

LA CO-ANIMATION



- Celui qui anime est concentré sur l'animation du groupe.
- Le co-animateur profite du recul dont il bénéficie : il peut venir appuyer l'animateur quand celui-ci est en difficulté (ex. à du mal à trouver ses mots...) ou pour dissiper un malentendu
- Les participants bénéficient de deux points de vue complémentaires qui vont enrichir les échanges
- L'alternance de personnalité, voix, visage donne du dynamisme à l'animation
- Le co-animateur, en position d'observateur peut perfectionner sa pratique de l'animation
- Le stress peut se répartir entre les deux co-animateur

- Sur le fond : les participants bénéficient de deux points de vue complémentaires qui vont enrichir les échanges
- Sur la forme, la co-animation donne du dynamisme du fait de l'alternance des personnalités, des voix, des visages.
- Autres co-animation présente aussi des intérêts :
 - Possibilité d'animer des groupes plus grands
 - Pendant que l'un anime, l'autre peut réfléchir, analyser, sentir et ...se reposer
 - La co-animation permet d'enrichir sa pratique de l'animation en observant l'autre animateur
 - Meilleure gestion du stress en la répartissant



Les règles de la co-animation

- Définir clairement les rôles respectifs
- Se coordonner soigneusement
- Co-exister
- Etre solidaires et éviter de se contredire devant les participants



AUTRES EXEMPLES D'OUTILS ÉDUCATIF



Visé à :

- Donner la parole à chaque patient et lui permettre d'exprimer un point de vue personnel
- Faire émerger des représentations en s'appuyant sur des images évocatrices
- Déculpabiliser le patient par l'absence de jugement
- L'aider à prendre conscience de son point de vue



Exprimer son ressenti par rapport à la maladie

PRELUDE

Je me sens
désemparé(e)



PRELUDE

Je suis
confiant(e)
dans l'avenir
grâce au
traitement.



PRELUDE

Je ne me
sens pas
malade.



PRELUDE

J'ai peur
de l'avenir
avec cette
maladie.



Identifier les symptômes de sa maladie



Je suis essoufflé(e)

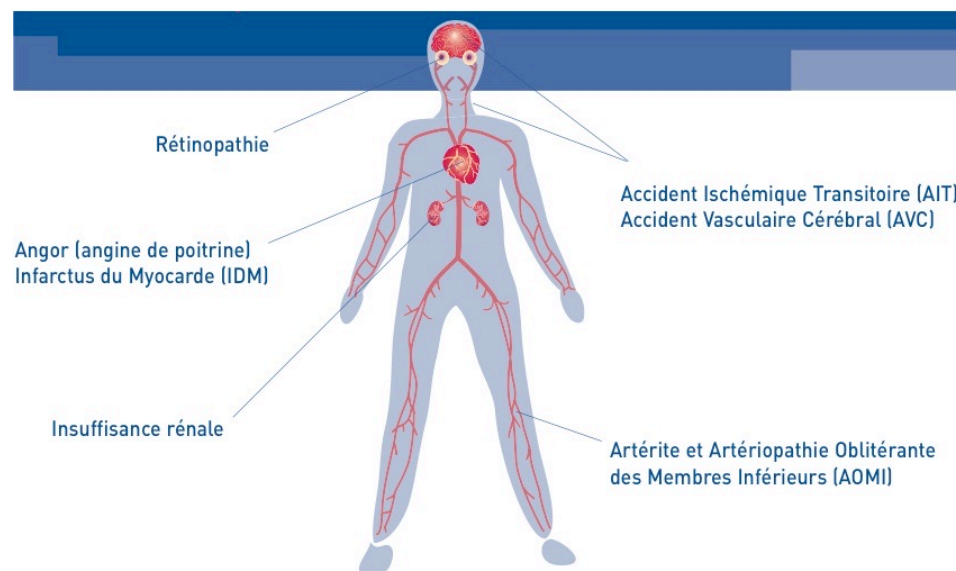


Je me sens faible



Je me sens fatigué(e)

Répertorier les répercussions



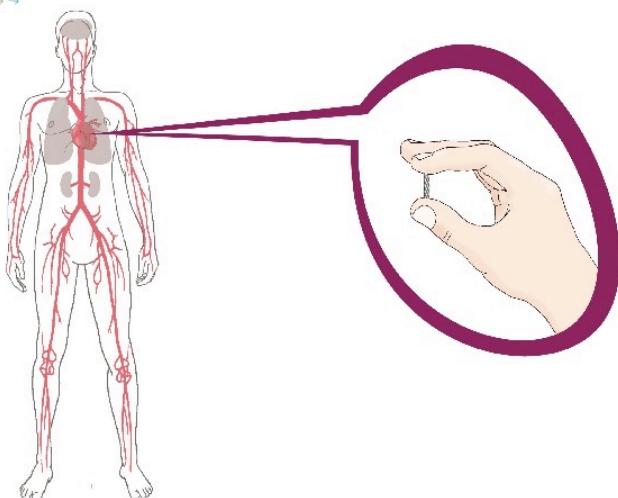
Les facteurs de risque de l'athérosclérose

→ → → → → → → →



Une maladie de toutes les artères : l'athérosclérose

→ → → → → → → →



PRELUDE



PRELUDE • PROGRAMME ÉDUCATIONNEL À L'USAGE DES DIABÉTIQUES

Cheeseburger

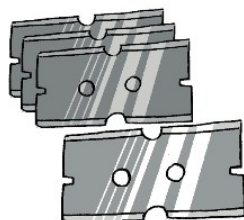
• carrés de beurre



• morceaux de sucre



PREL^UDE



Lames

PREL^UDE



Tabac

PREL^UDE



Mauvaise
hygiène

PREL^UDE



Chaussures

PREL^UDE



Râpes

Repérer les ennemis du pied- Tester ses propres chaussures pour se rendre compte des agressions possibles - Connaître les bons instruments pour ses pieds

PRELUDE



Roger se sent mal

Roger, âgé de 65 ans, a du diabète depuis 12 ans. Il prend régulièrement sa glycémie et note consciencieusement les résultats dans son carnet. Son médecin lui a prescrit un comprimé matin et soir.

Depuis deux jours Roger a des courbatures diffuses, de la fièvre et n'a pas d'appétit. Dès qu'il prend ses comprimés, il les vomit. Un matin il se lève et prend sa glycémie : 3,5 g/L ! D'habitude elle est toujours inférieure à 1,5.

1. Quel est le problème de Roger ?
2. Qu'est-ce qui a favorisé l'hyperglycémie ?
3. Qu'aurait dû faire Roger dès les premiers symptômes ?
4. Quels sont les risques encourus par Roger dans une telle situation ?

PRELUDE • PROGRAMME EDUCATIONNEL À L'USAGE DES DIABÉTIQUES

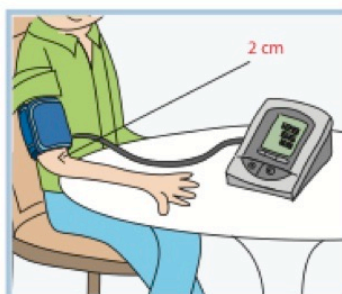
Etude de cas:

Comprendre l'intérêt de mesurer sa glycémie et d'apprendre à interpréter les résultats de la mesure glycémique et d'être capable d'agir dans différentes situations.

1. S'asseoir confortablement en installant l'appareil près de soi sur une table et se reposer 5 minutes.



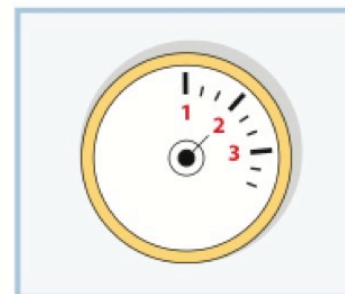
2. Poser son bras dénudé à hauteur du cœur, en position fléchie (ou, en cas d'utilisation d'un tensiomètre de poignet, poser son coude sur la table pour avoir son poignet à hauteur du cœur).



3. Enfiler le brassard deux doigts au-dessus du pli du coude. La taille du brassard doit être adaptée à celle du bras.



4. Serrer le brassard ni trop fort ni trop lâche, garder la main ouverte et appuyer sur « Start »



5. Laisser le brassard se gonfler puis se dégonfler sans bouger et en restant détendu. Renouveler la mesure trois fois à 1 ou 2 minutes d'intervalle.

L'automesure tensionnelle c'est :
3 mesures consécutives, le matin entre le lever et le petit-déjeuner
3 mesures consécutives, le soir entre le dîner et le coucher
3 jours de suite

L'AUTOMESURE TENSIONNELLE



AUTRES EXEMPLES DE TECHNIQUES D'ANIMATION



- BUTS :
- Rendre visible la discussion
- Faire gagner du temps
- Favoriser une forte implication des participants
- Permettre de prendre en compte toutes les opinions

(1970 - Schnelle)





Les règles de la discussion visualisée (Métaplan®)

- L'animateur présente l'objectif et précise la tâche à accomplir :
« à quoi vous fait penser le mot médicament »
en notant une idée par post-it, soit un mot, soit une expression limitée à 3 à 5 mots au plus
- Il présente la règle principale : ce qui sera affiché appartiendra au groupe et non plus aux personnes qui l'auront écrit.
- Il distribue post-its et feutres
- Les patients réfléchissent individuellement (fixer le temps)
- Chaque patient dispose (selon taille du groupe) de 3, 5 ou plus de post-its
- L'affichage s'effectue quand le groupe est prêt
- Ramasser les post-its, les mélanger si possible





Les règles du Métaplan® (suite)

- Lire les post-it un à un
- Afficher un post-it et laisser la salle réagir, ne pas hésiter à faire préciser un post-it
- L'animateur reste neutre (ni commentaire, ni refus)
- Il prend en compte toutes les propositions émises par le groupe
- Obtenir l'accord du groupe avant de continuer l'affichage
- Regrouper les post-its avec l'aide du groupe pour faire des ensembles, donner un titre à l'ensemble (avoir réfléchi en amont à ces regroupements)
ex : les aspects positifs des médicaments / les aspects négatifs
- La production devient celle du groupe (commune et anonyme)



Exemples d'application du Métaplan®

- pour explorer au préalable les représentations des patients sur symptômes de la sclérose en plaques et identifier les sphères atteintes
- « quels sont les symptômes dus à la SEP ? »
- Quelles en sont les causes et les conséquences?
- Relance possible : Comment a débuté votre maladie? Par quel trouble?



- Ensemble de photographies utilisées en groupe pour faciliter l'expression de l'opinion personnelle des participants à partir de leur perception d'une image





La Photoexpression vise à...

- Donner la parole à chaque patient et lui permettre d'exprimer un point de vue personnel
- Faire émerger des représentations, des émotions, des opinions en s'appuyant sur des images évocatrices
- Déculpabiliser le patient par l'absence de jugement
- L'aider à prendre conscience de son point de vue
- Lui permettre de relativiser en le confrontant à celui des autres





Règles d'utilisation

- L'animateur doit :
- Veiller au respect des paroles prononcées par chacun : pas de jugement, pas de transformation des propos
- Mettre en confiance les participants, éventuellement en participant au choix d'une photographie
- Permettre à chacun d'exprimer son opinion personnelle afin d'éviter un discours anonyme et stéréotypé
- Laisser la liberté aux membres du groupe de ne pas participer





Mise en place

- L'animateur explique les objectifs de l'animation, les règles de la communication, et l'organisation de la communication (voilà le but de..., cela va se dérouler comme cela..., chacun doit pouvoir expliquer son choix sans intervention, avis ou jugement des autres. La discussion se fera dans un 2e temps)
- Il formule la consigne (précise ++)
- L'animateur dispose les photos sur la table.
- Il invite les patients à s'approcher de la table





- Chaque patient choisit/repère en silence* une ou deux** photos qui correspondent selon lui à la question, sans les prendre dans un premier temps. (le patient note ou retient les numéros).
L'animateur précise que lorsqu'ils ont tous choisi, ils retournent s'asseoir en prenant la photo. Si 2 personnes ont pris la même photo, ils se repèrent et parleront chacun leur tour sur la même photo.
- Chaque patient est invité à saisir les photos choisies, à les montrer au reste du groupe et à les commenter (pourquoi il a fait ce choix, etc.).
- Le patient s'exprime comme il le souhaite pendant quelques minutes sans être interrompu.
L'animateur peut demander au patient qui s'exprime de reformuler ou de préciser s'il le juge nécessaire.

*En silence : chaque patient doit utiliser ses propres ressources pour faire son ou ses choix

**1 ou 2 photos : ce n'est pas plus facile pour eux lorsqu'ils doivent choisir un +gd nbre. En fait, on risque d'aller plus profondément avec un nombre restreint de photos

- Si quelqu'un ne souhaite pas prendre la parole, il est possible de prendre un joker, mais on reste dans le cercle de travail.
- On peut montrer aussi ses photos sans s'exprimer
- Une fois que tous les patients se sont exprimés, l'animateur demande aux participants comment ils ont vécu ce travail, que leur a-t-il apporté ?
« il ne s'agit pas d'évaluer, mais d'analyser ce que nous venons de vivre. (...) Avez-vous été intéressé par ce qui s'est dit ? A quels moments ? Que s'est-il passé lorsque nous avons constaté que vous aviez choisi la même photo que quelqu'un d'autre... ? »



Technique de la boule de neige (ou d'élaboration progressive)

- OBJECTIFS
- Réalise d'emblée la participation de chacun (ce que ne fait pas la participation à la cantonade souvent utilisée par défaut)
- Fait prendre conscience aux groupes de leur force de production, et de leurs connaissances antérieures si utilisées en début séance éducative
- Crée une ambiance de communication
- DEROULEMENT
- Individuelle, puis 2 par 2 discussion, puis 4 par 4 mise en commun et discussion, etc. si groupe plus important
- Un rapporteur par grand groupe au dernier stade
- C'est l'animateur qui fait la synthèse finale

- Développée par Tony Buzan, psychologue britannique, début 70's, à la suite de ses recherches sur l'apprentissage et le cerveau humain,
- méthode d'organisation des idées, sous forme de dessin ou d'arborescence, (Mind Map en anglais).
- Graphique représentant des idées, des tâches, des mots, des concepts qui sont liés entre eux autour d'un sujet central.
 - représentation non-linéaire qui permet d'organiser ses idées de façon intuitive autour d'un noyau central.
 - L'intérêt : pouvoir transformer une longue liste de tâches monotones en une représentation graphique colorée et attractive, plus facilement mémorisable et proposant une organisation claire de ses idées.
 - Articulées autour d'un noyau central, elles mettent en œuvre des lignes, des symboles, des mots, des couleurs et des images illustrant des concepts simples et faciles à mémoriser



Autres exemples d'outils d'évaluation

Tableau de suivi des activités

Nb de patients inclus (ayant bénéficié d'un bilan éducatif partagé)

Profil des patients (age sexe, niveau de précarité..)

% patients ayant fini le programme

Objectifs éducatifs atteints/ listés

Nb de séances, nb de patients par séances

% dossiers éducatifs complets

% synthèses adressées au médecin traitant

Temps dédié des intervenants (en équivalent temps plein)

Temps de formation de l'équipe et temps d'échange-concertation

- L'échelle de mesure **couramment** utilisée est celle de LIKERT

	Tout a fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas d'accord du tout	Sans opinion
Les informations prodiguées lors des séances sont applicables dans ma vie de tous les jours					

- Ou bien une échelle visuelle analogique

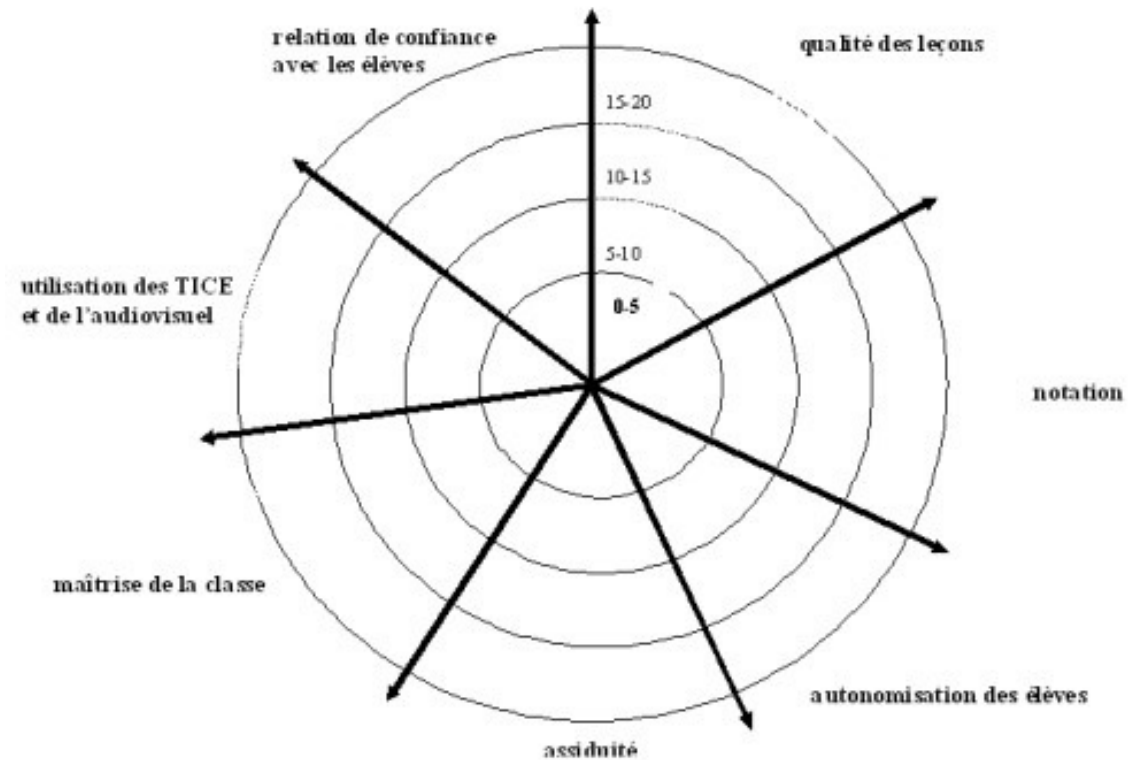


0 : désaccord total/insatisfaction

10 : accord total/satisfaction

Processus

- Présentation sur tableau de papier ou sur feuilles individuelles
- Le patient indique son accord total au centre, son désaccord total dans le 4ème cercle externe de la cible



AVANTAGES : opinion instantanée - INCONVENIENTS : moins précis

Objectifs

Qu'avez-vous
appris d'important
dans cet atelier ?

1.

2.

3.

Que pensez-
vous pouvoir
appliquer suite à
cet atelier ?

1.

2.

3.

Qu'avez-vous
appliqué suite à
cet atelier ?

1.

2.

3.

- Mettre en lumière les forces et les faiblesses du programme
- S'engager dans des actions de changement, d'amélioration et de pérennisation
- Prendre une décision concernant l'avenir du programme

- Transmise à l'ARS $\Rightarrow$ besoins d'accompagnement, réflexion territoriale...
- Utile aux équipes et coordonnateurs pour la prise de décision ($\Rightarrow$ amélioration ou ajustement du programme)
- Utile pour valoriser, promouvoir le programme notamment auprès des professionnels impliqués dans le parcours des patients
- Nécessaire à l'amélioration de la pratique d'ETP

- Coordonnateur du programme = responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de l'EQ
- Réflexion collective et participative au sein de l'équipe
- Auto-évaluation intégrée aux démarches d'amélioration de la qualité déjà en place
- Sollicitation des bénéficiaires et des professionnels de santé impliqués dans le parcours de soins

ÉVALUATION ANNUELLE

Évaluations tout au long du déroulement du programme

Réalisées chaque année par l'équipe et le coordonnateur en impliquant les bénéficiaires et les professionnels de santé du parcours.

- Améliorer les pratiques, l'organisation, le partage d'informations, la coordination.
- Et ajuster le programme au cours de son développement.



Mise en lumière des forces et des faiblesses du programme et suivi de la qualité de la mise en oeuvre du programme

DÉFINITION

FINALITÉS

ÉVALUATION QUADRIENNALE

Évaluation de bilan ou de synthèse

Réalisée par l'équipe et le coordonnateur la 4^e année de fonctionnement du programme en impliquant les bénéficiaires et les professionnels de santé du parcours.

- S'engager sur des actions de pérennisation, d'amélioration, des changements.
- Prendre une décision pour l'avenir du programme.



Mise en lumière des effets et des évolutions du fonctionnement, de la mise en oeuvre, de la coordination du programme, de sa structuration sur la période d'autorisation

ÉVALUATION ANNUELLE

Auto-évaluation participative, intégrée aux démarches d'amélioration de la qualité déjà en place

- Sélection chaque année par l'équipe des objets d'évaluation estimés importants pour la qualité du programme d'ETP mis en œuvre.
- Organisation et mise en œuvre d'un système de recueil de données quantitatives et qualitatives.

MODALITÉS

ÉVALUATION QUADRIENNALE

Auto-évaluation participative, intégrée aux démarches d'amélioration de la qualité déjà en place

- Réflexion systématique sur les effets et les évolutions du programme dans son contexte de mise en œuvre.
- Exploitation des données quantitatives et qualitatives.
- Organisation d'un recueil de données complémentaires auprès des bénéficiaires, des intervenants et des professionnels du parcours.

En résumé, particularités des 2 évaluations

ÉVALUATION ANNUELLE

Activité globale : bénéficiaires, intervenants, activités éducatives.

Processus : qualité des façons de procéder, respect et enchaînement des étapes de l'ETP, qualité des séances éducatives, partage de l'information, coordination.

Effets : atteinte des objectifs pédagogiques, satisfaction des bénéficiaires et des intervenants sur le déroulement du programme.

- Destiné au coordonnateur et à l'équipe, à la structure.
- Mis à disposition des bénéficiaires.
- Transmis à l'initiative de l'équipe et du coordonnateur à l'agence régionale de santé.

OBJETS D'ÉVALUATION

USAGES DU RAPPORT

ÉVALUATION QUADRIENNALE

Effets : changements habituellement attendus de la participation des bénéficiaires, conséquences sur le fonctionnement de l'équipe, intégration du programme dans l'offre de soins locale.

Évolutions du programme dans sa mise en œuvre et sa structuration en termes d'adaptation aux besoins des bénéficiaires et d'adéquation avec les recommandations et les textes réglementaires.

- Destiné au coordonnateur et à l'équipe, à la structure.
- Mis à disposition des bénéficiaires, des professionnels du parcours.
- Communiqué à l'agence régionale de santé

Évaluer l'atteinte des objectifs du patient



Que faut-il évaluer chez le patient

- Les apprentissages réalisés
- Les actions mises en œuvre
- Les bénéfices ressentis
- L'impact du programme sur la qualité de vie, les critères cliniques...

➔ Mettre en valeur les transformations du patient

Le patient est le premier concerné

Il doit participer à l'analyse des résultats et des décisions



SAVOIR : mémorisation de connaissances ponctuelles

- QCM
- Tests vrai-faux
- Tests vrai-faux avec mesure des degrés de certitude

Une crise d'asthme est grave quand :			
La Ventoline® ou le Bricanyl® ne me soulage pas	Vrai	Faux	Ne sait pas
Le Bécotide® ou le Pulmicort® ne me soulage pas	Vrai	Faux	Ne sait pas
Je n'ai pas assez de souffle pour parler	Vrai	Faux	Ne sait pas

- Il ne s'agit pas de créer des pièges.
- Les réponses sont soit des affirmations scientifiques, soit des erreurs courantes que le patient doit reconnaître comme telles

- Mesure la confiance que le patient accorde à sa connaissance :

Sauter un repas fait maigrir plus rapidement

☐ VRAI ☐ FAUX

A combien, êtes-vous sûr de votre réponse ?

25% 50% 75% 100%

- Dans l'autogestion de sa maladie, le patient va avoir tendance à n'appliquer que les connaissances dont il est sûr
- Intérêt de ce test :
 - Valorise le doute et favorise l'apprentissage
 - Permet de voir la disparition de l'incertitude et la montée de la certitude entre le début et la fin d'éducation

- Analyse par le patient de documents simulés :
 - Carnet de surveillance
 - Résultats biologiques
 - Imagier, menus...
- A partir desquelles
 - On pose des questions orales, des vrai-faux
 - On mesure sa capacité à interpréter des signes, des résultats...

- On mesure sa capacité à prendre des décisions
LE PATIENT EST UN DECIDEUR ET PARFOIS A RISQUE...
- Technique du récit : On demande au patient ce qui s'est passé d'imprévu par rapport à sa maladie ou son traitement et qu'il a eu à gérer dans l'urgence ou dans sa vie quotidienne
- Présentation de situation-problème
 - À partir d'exposé de cas
... Vous devez prendre l'avion. Vous savez que le décalage horaire est de 4 h. Quelles seront les précautions à prendre pour le voyage ? Comment adapterez-vous votre traitement ?
 - ⇒ Réponse soit orale, soit à choix multiple

Grille d'observation du geste

- Lister toutes les étapes du geste
 - Bien observer tous les éléments constitutifs du geste
 - Regrouper parfois certains items
 - Vérifier la commodité d'emploi par l'équipe
- Réponses possibles
 - Acquis/non acquis
 - Acquis/partiellement acquis/Non acquis
 - Bien fait/mal fait (ou tenté sans succès)/non fait (ou non tenté)
 - Acte parfaitement réalisé/Erreurs ou omissions pouvant entraîner pour le patient des conséquences préjudiciables/Erreurs ou omissions pouvant entraîner pour le patient des conséquences graves /Acte à caractère dangereux pour le patient
 - ...

Injection sous-cutanée avec un stylo de façon adéquate

Sortir le stylo du réfrigérateur			
Attendre 15 à 30 min pour que la solution contenue dans le stylo atteigne la température ambiante			
Lavez-vous les mains			
Nettoyez le site d'injection avec une compresse alcoolisée			
Positionner le stylo à 90° face au site d'injection choisi et appuyez fermement contre la peau			
Avec le pouce, presser le bouton sur le haut du stylo et relâcher immédiatement. Entendre le 1 ^{er} clic (qui signifie que l'injection commence)			
Maintenir le stylo contre la peau jusqu'au 2 ^e clic (qui signifie la fin de l'injection)			
Jeter le stylo dans un collecteur prévu à cet effet			

Recto = décision
(le patient choisit le nb de
cartes qu'il veut)

1) Exposé d'une situation-
problème
« *hier soir, je me suis couché à
1 h. Du coup j'ai fait la grasse
matinée. Ho là, là, il est 11h et
je n'ai pas fait mon insuline.
Que vais-je faire ?* »

2) Propositions de minimum
6 cartes décisions, au verso
desquelles sont décrites les
conséquences de la
décision que le patient a
prise

Verso = conséquences
positives, neutres, négatives

EXPLIQUER SA MALADIE A DES TIERS

- Donne des informations claires
- Vérifie la compréhension de son interlocuteur
- Répond aux questions de son interlocuteur
- Rassure son interlocuteur

ETABLIR UNE RELATION AVEC LES SOIGNANTS A L'HOPITAL

- Interroge les soignants sur leur rôle / identité
- Exprime ses difficultés de compréhension
- Pose des questions
- Répond aux questions des soignants de façon adaptée

AVEC, EN CONCLUSION, AUTO-EVALUATION PAR LE PATIENT :

« Que pensez-vous de votre manière de... ? »

Auto-efficacité perçue par le patient

Ce programme m'a rendu : Plus capable de participer au choix de mes médicaments avec mon médecin	☐ oui , j'en suis plus capable et je le fais ☐ oui , mais je ne le fais pas encore ☐ non , la formation n'a rien changé
Plus capable de comprendre l'intérêt d'une prise régulière de mes médicaments	☐ oui , j'en suis plus capable et je le fais ☐ oui , mais je ne le fais pas encore ☐ non , la formation n'a rien changé
Etc.	

d'après A. Deccache



Mener une séance d'évaluation individuelle

- Introduction
 - Se présenter
 - Préciser l'objectif de la rencontre, sa durée
 - Expliquer comment va se dérouler la rencontre avec le patient
- Déroulement
 - Reprendre les objectifs fixés lors du BEP
 - Valoriser les efforts et les réussites
 - Déculpabiliser et analyser les échecs ou difficultés
- Conclusion
 - Faire le bilan des acquisitions du patient et celles qui restent à faire

Valide/pertinent/adéquat

- il mesure effectivement l'objet qu'il prétend mesurer
- certains outils sont adaptés à l'évaluation des connaissances, d'autres à celle des décisions, etc.

Fiable/constant

- les résultats d'évaluation ne varient pas en fonction de qui évalue
- les questions posées sont suffisantes

Objectif

- construction collégiale pour éviter l'incohérence des résultats et la difficulté d'interprétation

Commode

facile à utiliser en pratique

Acceptable

- vérification sans sanction, respect du patient

